

06 - 03- Troubles psychiques de la grossesse et du post partum - Pr. Adali

Si on a le temps, on va étudier deux chapitres. Un sur la grossesse, les troubles psychiques de la grossesse et du postpartum. Et si on a le temps, on va faire un cours sur les troubles sexuels.

Savoir que les troubles psychiatriques ou psychiques, s'il vous plaît, les troubles psychiques de la grossesse et du postpartum. C'est un cours qui me tient beaucoup à cœur. C'est un chapitre que j'estime très important à connaître pour tout médecin généraliste et tout professionnel de la santé qui, un jour ou l'autre, va travailler dans une structure où il y a des femmes enceintes et des femmes qui viennent d'accoucher.

Que vous soyez gynécologue, sage-femme, infirmière en gynécologie, infirmière en néonates, infirmière en pédiatrie, médecin généraliste dans un centre de santé, infirmière responsable de la vaccination. C'est un chapitre très, très, très, très important. Pourquoi, à votre avis, on va étudier les troubles psychiques de la grossesse et du postpartum ? C'est fréquent, oui.

Pourquoi encore ? Oui, pourquoi il faut bien les gérer ? Les suicides, ça retentit non pas uniquement sur la femme enceinte ou qui vient d'accoucher, mais aussi sur le fœtus en intra-utérin. Pour le postpartum, c'est pour les nouveaux-nés ou les enfants qui viennent de naître, les nourrissons de façon générale. Ça ne retentit pas uniquement sur la patiente.

Quoi encore ? À votre avis, il y a un retentissement négatif uniquement sur la maman et sur le nouveau-né, le mari, l'élève, risque de divorce, sur le couple de façon générale, sur la famille. Pourquoi on étudie la grossesse et les troubles psychiatriques de la grossesse ? Pourquoi déjà il y a des femmes présentes des troubles psychiatriques au cours de la grossesse ou du postpartum ? Parce que la grossesse est un événement, qu'on le veut ou non, majeur dans la vie d'une femme. C'est un événement qui est caractérisé par des changements importants au niveau psychologique.

C'est la transition de statut jeune femme à statut maman ou mère, avec toute la connotation psychique qui l'accompagne. Qu'est-ce qui accompagne le statut mère ? Responsabilité, angoisse et crainte par rapport à quoi ? C'est-à-dire ? Pardon ? Ne pas pouvoir assumer son rôle correctement, ne pas savoir faire ? Qu'encre ? Des craintes et des soucis par rapport, si c'est en période de grossesse, à un fœtus qui n'est pas encore né, qu'elle sent les craintes, qu'à une femme enceinte, qu'elle perde le bébé ? Pardon ? Oui, que ce soit un nourrisson qui a des malformations, qu'il naisse prématurément, etc. Donc c'est des craintes et des soucis par rapport à son état de santé aussi, parce que quand on dit dans ces cultures chez nous, c'est que l'accouchement, il y a un dialecte qui dit que c'est une maman qui vient d'accoucher, c'est-à-dire au cours de la grossesse, et on ne poste pas 40 jours après le postpartum, c'est une période de risque pour la maman.

Elle est à un pas de sa tombe, parce que c'est le risque. Pourquoi c'est une période

culturellement difficile ? Parce qu'auparavant il y avait beaucoup de mortalité maternelle au cours de la grossesse et en postpartum immédiat. Donc c'est pour ça que c'est une période qui est culturellement enracinée, une période de crainte pour la vie de la maman.

C'est une période de bouleversements hormonaux, et on le sait très bien que les hormones sexuelles, oestrogènes, progestérone, ont une influence sur les neurotransmetteurs qui vont entraîner des symptomatologies psychiatriques. C'est une période de changement somatique, en fait le deuil d'un corps, supposons que c'était une personne qui avait un corps mince, un corps qui est plus potelé, des œdèmes, une prise de poids peut-être importante, donc c'est une transition somatique importante, avec tous les symptômes, les signes physiques de la grossesse. C'est vraiment une question, merci.

D'accord, donc c'est une période aussi de changement somatique au niveau du corps, tous les signes physiques de la grossesse, les signes sympathiques de la grossesse, tous les symptômes physiques que vous connaissez de la grossesse, et des changements familiaux. La naissance d'un enfant implique un changement total dans la vie d'un couple. Avant, c'était une chambre à coucher qui était réservée au papa et à la maman, mariée et sa femme.

Après l'accouchement, il y a l'introduction d'un petit être, un petit bout de choux, qui va bouleverser toute l'intimité du couple. Ils sont obligés de le mettre avec eux, soit sur le lit, soit la maman. Les situations les plus fréquentes, elle va chasser le papa de la chambre à coucher, elle va y rester avec le nourissant.

Donc c'est un changement familial et un changement aussi dans le statut social. Donc tous ces changements-là nécessitent une adaptation de la future maman ou de la maman à ses changements somatiques, hormonaux, psychologiques et autres. Cette adaptation-là ne va pas se faire sans conséquences psychiques, surtout chez les personnes qui ont une vulnérabilité psychologique à développer des troubles psychiatriques.

Quand est-ce qu'on parle de troubles psychiatriques ou psychiques, les deux se valent, de la grossesse et du postpartum, ça s'étend de la conception jusqu'à postpartum, un an après l'accouchement. Donc durant toute cette période-là, on va étudier tous les troubles psychiatriques qui peuvent survenir au cours de cette période. C'est une problématique assez insérieuse parce qu'elle constitue un enjeu majeur de santé publique de par les conséquences sur la maman et de par les conséquences aussi sur le bébé, surtout sur le nourrisson, au niveau développemental, surtout à court mais surtout au long terme chez l'enfant.

Et bien sûr, vu les retentissements sur la vie du couple. Les études ont montré que les femmes, de façon générale, sont plus à risque de présenter une maladie mentale sévère, grave, dans les trois mois qui suivent l'accouchement. Elles ont, dans l'année qui suit la naissance, c'est-à-dire en postpartum, deux fois plus de risque d'être hospitalisées en milieu psychiatrique.

Donc ça témoigne du fait que c'est une période de vulnérabilité chez la femme. La complication postnatale la plus fréquente, c'est la dépression du postpartum et elle a une fréquence très

élevée, 13%. Surtout, on voit la dépression du postpartum lors des premières semaines après l'accouchement.

Le risque est multiplié par trois par rapport à après un mois de l'accouchement. Le risque de récurrence, ce qui est extraordinaire et ce qui nous aide en tant que cliniciens, c'est que le risque de récurrence de la dépression du postpartum est élevé 30 à 50% lors des grossesses ultérieures. Donc si vous avez une femme qui a déjà, dans les antécédents, une dépression du postpartum, c'est une patiente à risque de redévelopper une deuxième fois lors d'une prochaine grossesse, une dépression du postpartum.

À part la dépression du postpartum, il y a ce qu'on appelle le blues du postpartum, on va voir c'est quoi. Très élevé aussi, 26 à 85%. La psychose postpartale, comme le nom l'indique, psychose, c'est-à-dire, on l'a dit la dernière fois, psychose, c'est une symptomatologie qui est caractérisée par quoi ? Pardon ? Oui, mademoiselle.

Le patient est inconscient de sa maladie, oui. Et que c'est caractérisé par un délire, par une désorganisation de la pensée. Donc la psychose du postpartum, heureusement qu'elle est moins fréquente que la dépression du postpartum, un de cas pour mille accouchements.

Bon, pour les troubles psychiques de la grossesse, il varie entre des réactions physiologiques mineures, à de réels troubles psychotiques. Les réactions psychologiques, pardon, mineures, souvent transitoires, souvent au premier trimestre, irritabilité, l'habileté émotionnelle, modification des conduites alimentaires, grignotage en vie, etc. Alors, comment on appelle ça, Blarbia ? L'ohyme.

Vous voyez que l'ohyme, ça existe. L'ohyme, c'est des troubles psychologiques mineurs de la grossesse. D'accord ? Une femme qui a de l'ohyme, ce n'est pas une femme qui fait semblant.

Est-ce que c'est clair ? Nos évènements gravidiques, oui, ils sont considérés comme des troubles psychiques, et aussi on peut les classer dans les troubles psychiques de la grossesse, ou aussi des troubles physiques, des symptômes physiques de la grossesse. Les deux situations se valent. Dans 50% des cas, dans les situations les plus graves, ce qu'on appelle l'hypérhémésis gravidum ou la gravidarum, je ne me rappelle plus du nom, c'est les situations où les vomissements gravidiques sont tellement graves, sont tellement fréquents que ça peut engendrer, ça peut engager le pronostic vital de la maman, et ça nécessite de façon générale une hospitalisation pour faire un remplissage, une hydratation, dans une chambre sombre, seule, avec possibilité aussi de prescrire des médicaments anti-hémétiques de type neuroleptique, d'accord ? Dans les formes modérées, allégères, généralement c'est supportable et ça disparaît au deuxième trimestre.

Les manifestations anxieuses, très fréquentes, ce sont des manifestations, comme on l'a dit au début du cours, qui sont en rapport avec, si c'est le premier trimestre, ça va être en rapport avec quoi ? Premier et deuxième trimestre ? Oui ? À votre avis, logiquement, en troisième trimestre, ça devrait être en rapport avec quoi, les soucis, l'anxiété ? L'accouchement,

accouchement normal, pathologique, césarienne, accouchement normal, quoi encore ? La mort aussi, si c'est une césarienne programmée, quelles sont les complications de l'accouchement ? Premier et deuxième trimestre, généralement ça va être quoi ? Fausses couches, malformations, fœtales. Le souci avec les manifestations anxieuses, c'est quoi ? C'est que l'anxiété peut déclencher des contractions, peut entraîner réellement des avortements ou des fausses couches, ou bien des accouchements prématures. C'est pour ça que toute thérapie physique, relaxation, préparation à l'accouchement, est la bienvenue chez une femme enceinte.

Les épisodes dépressifs, c'est-à-dire réels. Vous avez fait le cours de la dépression ? Donc les épisodes dépressifs en bonne et due forme, oui. On peut les voir au cours de la grossesse, 10 à 20 %. Généralement, ils sont d'intensité légère à moyenne.

Généralement, ça ne nécessite pas un traitement médical. On peut faire une psychothérapie de soutien, une psychothérapie cognitive ou comportementale. Les choses peuvent rentrer dans l'ordre.

Heureusement qu'au cours de la grossesse, les dépressions sévères, mélancoliques sont rares. On les voit surtout chez les patients qui ont déjà des antécédents de pathologies psychiatriques, notamment le trouble unipolaire, le trouble bipolaire. Ces patients-là peuvent nous faire des dépressions graves au cours de la grossesse.

Les troubles dépressifs de la grossesse sont caractérisés par surtout de la culpabilité par rapport au fait de ne pas pouvoir prendre en charge son enfant et un sentiment surtout d'incapacité par rapport à ça. Les troubles psychotiques, purs et durs aussi, heureusement qu'ils sont rares. Ils imposent généralement une hospitalisation pour stabiliser la patiente, mais aussi une surveillance obstétricale vraiment très stricte, vu le risque aussi de malformations suite au traitement qu'on va donner pour traiter l'épisode psychotique.

Ça nous arrive souvent d'hospitaliser des femmes enceintes parce que les patients, par exemple, de schizophrène bipolaire, elles peuvent aussi tomber enceintes, elles ont le droit de tomber enceintes, elles peuvent faire des décompensations de leur maladie au cours de la grossesse. Ça nous arrive souvent de gérer, d'hospitaliser des patients enceintes. En postpartum, il y a d'abord ce qu'on appelle le blues du postpartum, ou bien le baby blues.

Blues du postpartum, c'est la nomenclature d'ASM nouvelle, mais anciennement appelée, ça garde toujours la même importance, syndrome du troisième jour, baby blues. Vous avez déjà entendu parler du baby blues ? Non. On va faire une comparaison pour bien expliquer les choses.

Excusez-moi. On va faire une comparaison entre blues du postpartum et dépression du postpartum. Il faut savoir que dans le blues du postpartum, on trouve une symptomatologie dépressive, d'intensité légère, vraiment très légère, et c'est une symptomatologie qui est transitoire.

Généralement, elle est spontanément résolutive en quatre à sept jours. Généralement, un blues du postpartum ne dépasse pas sept à dix jours. On parle de dépression du postpartum quand ? Le blues du postpartum et la dépression du postpartum diffèrent en termes de durée.

Le blues a sept jours. La dépression du postpartum, on parle de dépression du postpartum à partir de combien de jours ? Deux semaines. Oui ou non ? On parle de dépression de façon générale à partir de deux semaines.

Vous ne pouvez pas parler de dépression du postpartum si vous avez une symptomatologie dépressive inférieure à quinze jours. Première différence, Binezo. Une deuxième caractéristique, pardon, du blues du postpartum, c'est qu'il y a ce qu'on appelle de la labilité de l'humeur.

C'est un passage. La labilité. Je te cherche à la bille.

Qui change facilement. On peut passer d'un état de pleurs et de tristesse rapidement d'un état de pleurs et de tristesse à un état d'euphorie. J'ai un exemple très schématique, très clair d'une labilité chimique chez une patiente qui faisait du baby blues.

C'était une patiente qui était en train de nous parler. Ce n'est pas une patiente, c'est quelqu'un que je connais qui a fait un blues du postpartum et j'ai pu décoder ça quand je lui ai rendu visite. C'est une personne qui était en train, on était en train de rigoler, elle était en train de rire et soudainement, elle avait les larmes aux yeux.

Elle était en train de sourire et en même temps, elle avait les larmes aux yeux. Et elle disait que je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne ressens pas de la tristesse, mais elle avait quand même les larmes aux yeux. Donc rapidement, elle est sautée de l'euphorie aux larmes.

D'accord ? Avec une irritabilité, anxiété et surtout un sentiment d'incapacité, une fatigue par rapport à la prise en charge du bébé, une asthénie, des plaintes somatiques. Par rapport à la dépression, quand on a des symptômes de tristesse, quand on a un baby blues qui dépasse deux semaines, ce n'est plus un baby blues, c'est quoi ? C'est une dépression du postpartum. Là, la dépression du postpartum, c'est comme, les symptômes sont comme la dépression, l'épisode dépressif caractérisé que vous avez fait en cours.

D'accord ? Il y a l'humeur dépressive, l'anédonie, etc. Sauf que dans la dépression du postpartum, il y a certaines caractéristiques. Il y a, excusez-moi, une asthénie importante, ce qu'on appelle une phobie d'impulsion.

Vous savez la phobie d'impulsion ? La phobie d'impulsion, c'est une peur, la phobie, c'est une peur exagérée, irrationnelle, d'impulsion, de commettre des actes impulsifs, agressifs envers l'enfant. Les mamans, elles ont peur de, quand elles prennent leur enfant, qu'elles lui fassent du mal. Elles ont peur qu'elles l'étouffent.

Elles ont peur de faire un acte impulsif, non contrôlable, et qu'elles fassent peur, qu'elles

fassent mal à leurs enfants. Il y a la phobie d'impulsion. Un sentiment d'incapacité, autodévalorisation, auto-accusation, toujours, généralement, dans la grande majorité des cas, ce sentiment-là, il est par rapport à ? La culpabilité, c'est par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Par rapport à la responsabilité de maman.

Un sentiment d'autodévalorisation, je ne vauds rien, je ne pourrai pas, je ne suis pas comme les autres mamans qui vont bien s'occuper de leurs enfants, je suis trop faible pour faire ça, je n'ai pas les habiletés pour faire ça, je ne serai pas une bonne maman, etc. Donc, les sentiments que vous avez vus d'auto-accusation, d'autodévalorisation, d'autodépréciation, ils concernent souvent la capacité à la prise en charge du bébé. Un autre élément qui pourrait caractériser la dépression du postpartum, c'est des symptômes que présenteront les nourissants et qui peuvent nous orienter vers une dépression chez la maman, notamment des coliques chez le nourissant, des pleurs inexpliqués chez le nourissant, des troubles du sommeil grave et de l'alimentation chez le nourissant.

Un bébé qui est ramené souvent en consultation de médecine générale ou bien en consultation pédiatrique pour des coliques fréquentes graves, intenses, pour des troubles de l'alimentation graves, intenses, pour des troubles du sommeil, c'est-à-dire un bébé qui pleure jour et nuit, qui ne dort pas bien, qui ne mange pas bien, qui a des coliques, il faut suspecter une dépression chez la maman, la lèche. La lèche, c'est-à-dire le mal-temps ? Et pourquoi ça, un retentissement sur les symptômes, des symptômes physiques chez le nourissant ? Oui, c'est un trouble de l'interaction entre bébé, entre nourissant et sa maman. Il faut savoir aussi que les nourissants, les enfants bas âge, peuvent développer des dépressions néonatales, ils peuvent développer des troubles psychiques en néonatale ou à n'importe quel âge, et ces symptômes psychiques-là, cette souffrance psychique ailée, elle se manifeste chez le nourissant par des symptomatologies somatiques, surtout des troubles du sommeil.

Ça peut aussi être quoi ? Ça peut aussi être une dépression, une souffrance au cours de la grossesse chez la maman, et qui pourrait entraîner des complications psychiques et somatiques chez le nourissant à la naissance. Donc vous voyez que dès maintenant, je vous le dis, quand on est devant une dépression au cours de la grossesse, surtout si c'est une dépression d'intensité assez sévère, et qu'on est obligé, quand il y a l'indication d'un traitement médical, vous allez le voir en cours d'antidépresseurs que les antidépresseurs sont généralement contre-indiqués au cours de la grossesse. Il y a très peu d'antidépresseurs qui sont, déjà il y a des antidépresseurs qui sont contre-indiqués formellement au premier trimestre de la grossesse.

Vous allez voir que les antidépresseurs sont contre-indiqués au cours de la grossesse, vu le risque de troubles neurodéveloppementaux chez le nourissant. Ce ne sont même pas les malformations somatiques, mais surtout les troubles neurodéveloppementaux chez le nourissant. Vous allez voir aussi, d'un autre côté, que la dépression non traitée au cours de la grossesse peut entraîner des troubles neurodéveloppementaux.

Donc vous voyez qu'on est devant une balance, faut-il ou pas prescrire un traitement antidépresseur. Donc la dépression peut avoir des conséquences néfastes sur le développement neurologique et le neurodéveloppement du nourissant. La mélancolie du postpartum, heureusement qu'elle est rare, 1% des cas.

Bien sûr, vous savez très bien c'est quoi la mélancolie, c'est une dépression sévère, grave, etc. Vous l'avez vu, vous le connaissez mieux que moi. Cependant, il y a certaines particularités.

C'est qu'on a des thématiques, vous savez, on vous a enseigné que dans la dépression mélancolique, il y a le délire, oui ou non ? Oui ou non ? La thématique délirante, elle est surtout centrée sur le bébé. Dans plusieurs situations, les mamans ont la conviction délirante quand on leur a substitué leur enfant par un diable. L'idée que leur enfant est empoisonné, il est envoûté.

Ou sur la filiation, ce n'est pas mon enfant, c'est un enfant de Dieu, ce n'est pas mon vrai enfant, de négation aussi de filiation, d'accord ? Les angoisses de port, la peur que son enfant meure est très importante. Elle peut aussi s'accompagner d'idées suicidaires. Le risque dans la mélancolie délirante, c'est le suicide, mais surtout l'infanticide.

Quelle est la logique dans l'infanticide ? Pardon ? Oui, c'est une sale façon. C'est très douloureux, la vie est douloureuse, la vie est dure, pénible, etc. Vaut mieux que je parte, mais je ne peux pas partir et le laisser seul, donc vaut mieux que je l'emporte avec moi.

C'est ça la logique de l'infanticide dans la mélancolie du postpartum. Très fréquente, très grave. On a eu beaucoup de situations d'infanticides, malheureusement.

On a hospitalisé beaucoup de patients pour des tentatives d'infanticides assez graves, traumatisantes pour le nourrisson, même un infanticide par rapport au nourrisson qui vient de naître et aussi aux autres enfants. Donc c'est très difficile de gérer ce genre de situation. La psychose du postpartum, appelée anciennement psychose purpurale, psychose comme on l'a dit, c'est par rapport au délire, désorganisation de la pensée, instabilité, etc.

Postpartum, c'est après l'accouchement. C'est le trouble le plus sévère et heureusement le trouble le plus rare. Le début est brutal, 48 heures, 72 heures après la naissance.

Ça peut commencer par des troubles du sommeil, ça peut commencer de façon un peu rapidement progressive. Troubles du sommeil, irritabilité, désintérêt par rapport à l'enfant, dans la phase d'état, tableau polymorphe, délire, alternance, un syndrome délirant qui a des mécanismes polymorphes, thématiques surtout centrées sur la maternité, sur l'accouchement, sur l'enfant qui est considéré comme un persécuteur. Contrairement à la mélancolie du postpartum, on a peur pour l'enfant, l'angoisse de mort par rapport à l'enfant.

Il est envoûté, il est empoisonné, c'est un enfant bréil, la maman a peur pour l'enfant. Dans la majorité des cas dans la psychose du postpartum, l'enfant est perçu comme un persécuteur, comme un diable. Un diable est incarné en lui et cet enfant-là est là pour faire mal à la maman.

Le risque aussi de l'infanticide est fréquent. Hallucinations, comportements désorganisés, des manifestations timides qui peuvent alterner entre tristesse et euphorie. Cependant, il y a un red flag, un élément important à considérer quand on pose le diagnostic de psychose du postpartum.

Lequel ? De par le début des symptômes. On avait dit que c'est 48 à 72 heures en postpartum. Alors, red flag.

Attention, faire attention. À quoi ? 48 à 72 heures. À quoi on devrait penser ? Pardon ? À quoi on devrait penser ? 48 à 72 heures.

Avec ce tableau-là, à quoi vous devez penser ? LH-AVC. Oui. Un thrombophlébite cérébral.

LH-AVC. LH-thrombophlébite. Oui, vous avez raison.

Le risque de thrombophlébite en postpartum est élevé. Est-ce que ça va donner ce tableau-là ? Est-ce que ça va donner ce tableau ? Oui. Vous avez raison.

Oui, ça peut donner un tableau psychiatrique, tableau de délire, de désorganisation et de troubles du comportement. Thrombophlébite cérébrale en premier. Quoi encore ? LH-thrombophlébite cérébrale.

Je vous ai dit que par rapport au mode de début, 48 à 72 heures, c'est une symptomatologie psychiatrique d'apparition brutale en postpartum immédiat. Donc, le premier diagnostic auquel vous devez penser, c'est quoi ? C'est organique. C'est organique jusqu'à preuve du contraire.

Notamment, il faut éliminer une thrombophlébite cérébrale parce que c'est très fréquent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer le diagnostic de thrombophlébite cérébrale ? En jouant IRN. Quoi encore ? À quoi vous devez penser ? Oui, très bien.

Quel type d'infection ? Allez, je vais vous donner une infection neuro-méningite. Quel est le point de départ ? Gynécologique, oui ou non ? Une septicémie ? Vous savez, quand je dis récemment, il n'y a même pas trois mois, il n'y a même pas deux mois. Il n'y a même pas un mois.

On a reçu une patiente au service extrêmement agitée, en postpartum. C'était trois, quatre jours, je crois, du postpartum. Extrêmement agitée, délirante, propos incohérents, etc.

Hospitalisée. On n'a pas pu faire l'enjeu IRN parce qu'elle était extrêmement agitée. L'enjeu IRN, je vais vous épargner les problématiques techniques qu'on a au niveau du CHU.

Donc, on ne pouvait pas faire l'enjeu IRN parce qu'elle était agitée. Le lendemain, elle s'est calmée. On a fait l'enjeu IRN normal.

Examen gynécologique avec écho-pelvienne. Qu'est-ce qu'elle montre ? Des signes de péritonite avec une infection, une endométrite avec une péritonite. CRP élevé, patiente

apéritique, n'est pas fébrile.

CRP élevé, bilan infectieux perturbé. Bilan infectieux positif plutôt. Qu'est-ce qui a entraîné les troubles de comportement chez cette patiente ? Une septicémie.

La patiente a présenté une septicémie. L'enjeu IRN était normal. Il n'y avait aucun signe d'infection neuroménage.

Une septicémie peut entraîner de l'agitation. Deux diagnostics à éliminer, thrombophlébite et toute pathologie infectieuse. Généralement, la pathologie infectieuse est un point de départ gynécologique, surtout quand vous avez des patientes qui ont accouché chez elles.

Les éléments qui étaient aussi en faveur d'un problème organique chez cette patiente, c'est qu'elle avait zéro antécédent psychiatrique personnel. Accouchement antérieur, normal. Postpartum, pas de problème.

Est-ce que c'est clair ? Le tableau de psychose du postpartum, c'est une urgence diagnostique. Vous devez savoir pourquoi cette patiente présente un tableau de psychose. Est-ce que c'est d'origine psychiatrique ? Est-ce que c'est d'origine organique et thérapeutique aussi ? Parce que si c'est d'origine organique, il faut commencer le traitement rapidement.

Si c'est d'origine psychiatrique, il faut aussi hospitaliser pour commencer le traitement rapidement, vu le risque de complications d'infanticide et de suicide chez la maman et chez le nouveau-né. Il y a aussi un autre type de dépression qu'on ne cherche pas vraiment, on ne cherche pas beaucoup, on considère que c'est normal, c'est les dépressions après avortement. Que ce soit une interruption volontaire de la grossesse ou une interruption médicalisée de la grossesse ou carrément une grossesse arrêtée spontanément.

C'est les dépressions en rapport avec les avortements. C'est un événement assez traumatique pour la maman. Elle-même, pourquoi à votre avis il est traumatique ? Elle-même, qu'est-ce qui pourrait causer une dépression après l'avortement ? La culpabilité par rapport à quoi ? Oui, vous avez raison.

La décision, si c'est un avortement spontané, c'est-à-dire que ce n'est pas elle qui a fait l'avortement de façon... Si c'est un avortement spontané ou la thérapeutique, parce qu'elle a fait une fausse couche, grossesse arrêtée, ils ont dû... Quand je dis avortement thérapeutique, c'est quand il y a une contre-indication absolue à ce que la grossesse soit continue. Exemple. Pardon ? Non.

La mort déjà qu'il y en a. On fait un avortement alors que la grossesse n'est pas arrêtée. Elle est évolutive, oui. Et on fait une interruption médicale.

Oui, j'ai eu. Pardon ? Non, supposons que c'est le premier trimestre. Retard de croissance, ça n'entraîne pas.

La prise d'un médicament thérapeutique. Vous savez que la prise, par exemple, de la dépakine du valproate de sodium, ça peut être une indication formelle à arrêter une grossesse. Parce que le risque de malformation, il est important.

Une patiente sous chimiothérapie et qui est tombée enceinte. Radiothérapie, tombée enceinte. Donc, il y a des situations particulières.

Heureusement que c'est rare, vu les avancées scientifiques, vu qu'on fait plus de... l'éducation par rapport à les patientes. Mais ça reste aussi des situations fréquentes. Pourquoi la culpabilité si c'est une grossesse, un avortement naturel, une grossesse arrêtée de façon spontanée ? Culpabilité par rapport à qu'est-ce que j'ai fait pour que ma grossesse soit arrêtée.

Que la patiente le veuille ou non, il y aura toujours ce questionnement. Est-ce que je n'ai pas pu prendre soin de moi ? Si elle ne savait pas qu'elle était enceinte, comment ça se fait que je n'ai pas su, je n'ai pas suspecté que j'étais enceinte, donc je n'ai pas fait ce qu'il faut ? J'ai pris des médicaments alors que je ne savais pas que j'étais enceinte. Donc il y a toujours ce sentiment de culpabilité.

Il y a un autre élément qui fait que ce sont des grossesses qui peuvent entraîner des dépressions et que c'est vécu de façon traumatisante. Lequel ? Pardon ? Oui, le choc, mais tout en... Oui, elle avait imaginé cet enfant, elle avait cette anticipation, cette attente, oui. Mais le culpabilisant voulait dire oui.

Il y a un autre élément qui va rendre cet événement traumatisant, c'est le fait qu'on ne puisse pas faire le deuil de cet enfant. Je vais vous expliquer. Est-ce qu'on ne peut pas faire le deuil de cet enfant ? Ce n'est pas un enfant qu'on a vu, il n'y a pas eu de funérailles, oui ou non ? L'intérêt de faire le deuil, je vais vous l'expliquer autrement.

Vous savez que les personnes qui perdent un membre de la famille sont dans une catastrophe naturelle, soit dans un crash d'avion, c'est-à-dire toutes les situations où on ne peut pas trouver le corps de la personne décédée. Donc, on ne peut pas faire des funérailles, on ne peut pas l'enterrer, donc on ne peut pas le voir pour lui dire au revoir, pour lui dire nos adieux. Et ça, qu'est-ce que ça entraîne ? Ça va entraîner que le deuil ne se fasse pas, parce que le fait d'aller dire au revoir à la personne décédée et de voir des gens qui viennent à la maison pour présenter leurs condoléances, qu'on amène le défunt au cimetière, qu'on l'enterre, tout ça, c'est des éléments du deuil qui vont ancrer dans notre tête que cette personne-là est partie.

Et ça va faciliter le deuil après. Dans les situations où on ne trouve pas le corps, par exemple, de la personne défunte, surtout si c'est quelqu'un de très proche, les familles ne peuvent pas faire leur deuil. Vous savez que dans l'approche psychothérapeutique pour ces patients-là, ces familles-là qui n'arrivent pas à faire leur deuil et qui peuvent se compliquer par un état de stress post-traumatique, par un état de stress aigu par une dépression après, qu'est-ce qu'on fait ? Aux États-Unis ou en France, ils font des funérailles imaginaires.

Toutes les personnes qui ont perdu un âge, comment on appelle ça ? Le nom m'échappe. C'est-à-dire qu'on peut construire un statut, par exemple, une statuette qui représente, là où c'est écrit les noms de toutes les personnes qui étaient disparues, par exemple, qui sont mortes. Et là, c'est un lieu de recueillement des familles.

C'est comme l'équivalent d'une tombe où ils peuvent pleurer, parler aux défunts. C'est comme des funérailles imaginaires. Parfois, en thérapie, on peut demander aussi aux membres de la famille X d'imaginer qu'il est devant la personne qui est décédée.

Qu'est-ce que vous aimez lui dire ? Qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Et là, les personnes vont dire au revoir, pardonne-moi, je n'ai pas pu lui dire au revoir, je n'ai pas pu lui dire moussamaha, je n'ai pas pu ça, ça et ça. Et ça renforce le deuil. Le deuil est un processus naturel qui doit s'accomplir.

Le souci avec les avortements, c'est que les mamans, comme les victimes de crash d'avion, n'arrivent pas à faire leur deuil, parce que l'avortement est fait, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de funérailles, et là, elle n'a pas vu son enfant, et elle ne l'a pas enterré. Donc, elle ne va pas arriver à ancrer le deuil en tête. Est-ce que c'est clair ? Donc, dans ces situations-là, le risque aussi, c'est les angoisses et les dépressions lors des grossesses ultérieures, où il y a toujours cette hantise-là de faire des fausses couches, de perdre l'enfant lors des grossesses ultérieures.

Donc là aussi, il faut faire attention chez les patients qui ont déjà des antécédents de fausses couches avec dépression post-fausses couches. Donc là, c'est des patients à risque de développer des dépressions de la grossesse ou du post-partum ultérieurement. Beaucoup de facteurs, on vous l'a bien expliqué, il n'y a pas un modèle explicatif, un seul modèle qui explique les troubles psychiatriques.

Cependant, il y a des facteurs de vulnérabilité qui vont plus ou moins prédire qu'une personne X va développer un trouble psychiatrique de la grossesse ou du post-partum. C'est les antécédents de carences, de violences physiques ou psychiques au cours de l'enfance. Les antécédents surtout personnels ou familiaux de troubles psychiatriques, c'est important.

Une personne schizophrène a beaucoup de risques de développer une rechute au cours de la grossesse ou au cours du post-partum. La consommation de toxiques, les facteurs biologiques dont on a parlé, c'est les changements hormonaux, mais pas uniquement, surtout au post-partum, pas uniquement les changements hormonaux, mais les changements hormonaux rapides, c'est la chute. Quand il y a des symptômes psychiatriques le quatrième jour, les baby blues ou la blues du post-partum, c'est parce qu'il y a une chute rapide des hormones de la grossesse qui maintenait un certain équilibre.

Cette chute rapide va entraîner des troubles psychiatriques. Les facteurs gynécologiques et médicaux, ce sont des facteurs de risque, de primiparité, des antécédents de fausses couches, on a bien expliqué, des suspicions de malformations, les antécédents d'accouchement primaturé, les accouchements actuels dystociques, les césariennes, surtout chez les patientes

qui ont fait des césariennes d'urgence, des césariennes aussi sous anesthésie générale est un facteur de risque, et toutes les pathologies chroniques durant la grossesse, notamment une patiente enceinte qui a une maladie de système, patiente enceinte qui est épileptique, diabétique et enceinte, elles sont plus à risque de développer des troubles. Grossesse non désirée, grossesse à un âge très jeune, mère célibataire, une famille qui n'est pas soutenante, conflits conjugaux, un antécédent d'un décès d'un enfant, un deuil proche, les personnes qui ont perdu un parent au cours de la grossesse ou là juste avant la grossesse, des événements de vie stressants pendant la grossesse.

Donc tous ces éléments-là, pourquoi on les étudie à des facteurs de risque ? On peut prévenir des troubles psychiatriques, dépister plutôt précocement, parce que le souci avec les... Prenons l'exemple de la dépression du postpartum. Le souci avec la dépression du postpartum, c'est quoi ? C'est quoi ? Pardon ? Retard consultation. LH ? Non, ce n'est pas la principale cause.

Rappelez-vous des symptômes qu'on avait dit qui caractérisent la dépression du postpartum, c'est ? Par quoi ça commence ? Troubles du sommeil, de la fatigue, de l'irritabilité. Alors, est-ce que c'est spécifique à la dépression ? D'accord. Ça peut être pré... Pourquoi ? Pour des symptômes normaux du manque de sommeil, la fatigue après l'accouchement.

L'enfant ne dort pas, donc elle non plus ne dort pas, donc le lendemain c'est normal qu'elle soit irritable. Donc c'est ça. C'est qu'on prend ça comme étant normal après l'accouchement.

Toutes les femmes sont fatiguées après l'accouchement. Toutes les femmes sont irritables. Toutes les femmes pleurent après l'accouchement.

La pauvre ne dort pas, son bébé ne la laisse pas dormir. Alors qu'elle est en train de faire de réels épisodes dépressifs. Et quand ce n'est pas traité à temps, le risque de passage à la chronicisation et quand une dépression passe à la chronicité, il y a généralement de mauvais pronostic.

Quand on ne traite pas précocement, le pronostic est mauvais. Les complications pendant la grossesse. Rappelez-vous, on en a parlé.

C'est une cause fréquente d'accouchement prématuré, bas poids à la naissance. Chez l'enfant, c'est des troubles du comportement, troubles neurodéveloppementaux. Plus tard, c'est des troubles d'apprentissage, troubles des comportements, troubles émotionnels.

En postpartum, on a vu affection de la qualité de vie, atténuation de la qualité de vie du fonctionnement du couple. Troubles de l'interaction mère-enfant. Des causes de maltraitance de l'enfant, ne serait-ce que par le fait de lui crier dessus.

On n'est pas obligé. La maltraitance englobe aussi l'agressivité verbale vers l'enfant. Dans un nourissant, vous lui criez dessus.

Ce n'est pas carrément la maltraitance physique, mais surtout verbale. La prise en charge. Le

premier élément de prise en charge, c'est la prévention et le dépistage.

Important. Quand est-ce qu'on fait le dépistage ? Est-ce que vous devez, en tant que médecin généraliste, faire le dépistage ? Le suivi. En tant que médecin généraliste, c'est vous qui assurez le suivi de beaucoup de grossesses.

Au cours des consultations de suivi de grossesse, lors des premières consultations au postpartum, soit pour des soins pour la maman, soit lors des consultations chez eux, nourrissons le nouveau-né. Vaccination ou infection chez le nouveau-né, saisissez l'occasion pour faire un dépistage rapide. Il y a un questionnaire, on avait fait une thèse sur la dépression du postpartum, il y a un questionnaire rapide, facile à remplir, que vous pouvez utiliser en consultation chez les mamans.

Bien sûr, quand vous allez faire le dépistage, vous commencez d'abord par la recherche de facteurs de risque qu'on a vus tout à l'heure. La prescription de psychotropes, on l'avait dit, ils ont un effet tératogène au cours de la grossesse pour certains médicaments, surtout en premier trimestre, notamment la paroxythine, palproate de sodium, certains antipsychotiques ou drogue leptique. La prescription aussi de certains psychotropes, notamment les benzodiazépines, pour entraîner un syndrome de sevrage en néonatal.

C'est un nourrisson qui prenait, chez qui les benzodiazépines passaient au cours de la grossesse. Et puis après, à l'accouchement, vous l'arrêtez brutalement, ça va entraîner un syndrome de sevrage. Le syndrome de sevrage est très grave en néonatal, ça peut entraîner des crises convulsives qui peuvent aller jusqu'au coma et au décès du nouveau-né.

Et bien sûr, les symptômes psychomoteurs, altération du développement psychomoteur cognitif et ou émotionnel à long terme. Donc, quand vous voulez prescrire des psychotropes au cours de la grossesse, surtout au cours de la grossesse, il faut évaluer le rapport bénéfice-prix. Rappelez-vous, prescrire un antidépresseur alors que ça peut donner des malformations, des troubles neurodéveloppementaux, ou bien laisser la patiente déprimée et la dépression entraîne des troubles neurodéveloppementaux.

Donc, privilégiez toujours une approche au cours de la grossesse, une approche psychothérapie de soutien, TCC, psychothérapie cognitive ou comportementale, avec surveillance régulière de l'état de la patiente. Si elle s'aggrave, s'il faut prescrire un antidépresseur, n'hésitez pas à le faire. Parce qu'une dépression aussi chronique, une dépression non traitée chez une femme enceinte, peut s'aggraver et peut s'aggraver vers une dépression sévère ou mélancolique et là les conséquences sont graves.

En prescrivant des psychotropes au cours de la grossesse, il faut choisir les molécules qui ont le plus de recul. Les antidépresseurs par exemple qui sont indiqués, c'est les anciennes molécules qui ont le plus de recul, notamment la fluoxétine, la sertraline. La fluoxétine est contre-indiquée en premier trimestre.

Commencez par la posologie efficace la plus faible, on commence moitié dose, on voit la tolérance, on voit l'évolution, puis après si on a besoin d'augmenter la dose, on l'augmente. Donc avec une surveillance rapprochée de l'état psychique de la patiente et une surveillance échographique et gynécologique étroite aussi. En fin de grossesse, diminuer les posologies, surveiller le développement bien sûr fatal par des échographies et au cours, en postpartum, il est conseillé d'arrêter le traitement, pardon l'allaitement.

Personnellement, au cours de la grossesse, quand je n'ai pas le choix, je prescris un antidépresseur. S'il faut prescrire, il le faut tout en sachant qu'il faut avoir le consentement éclairé de la maman, lui expliquer tous les risques avec l'antidépresseur et c'est elle qui décide. En postpartum, je ne prescris, c'est une conduite à tenir personnelle.

Beaucoup de psychiatres prescrivent un antidépresseur tout en encourageant l'allaitement. Personnellement, parce que l'allaitement n'est pas une contre-indication absolue, c'est relatif, au cas par cas, c'est à vous de décider. Personnellement, j'arrête, je ne prescris l'antidépresseur que si la maman a fait le sevrage, a arrêté l'allaitement.

C'est une conduite personnelle. Je dis que quand je peux épargner à un nouveau-né ou à un enfant un traitement psychotrope dont il n'a pas besoin, je le fais. Pendant la grossesse, on n'a pas le choix.

En postpartum, j'ai le choix d'arrêter l'allaitement et d'empêcher ce passage du psychotrope à l'enfant. Ça, c'est une conduite personnelle. Beaucoup d'autres médecins prescrivent des antidépresseurs au cours de l'allaitement.

J'ai eu un grand souci avec une amie psychiatre sur Casablanca qui m'avait adressé une de ses parentes à elle qui était en voyage à Marrakech et qui n'avait pas son ordonnance et qui avait oublié son traitement antidépresseur. Elle me l'a envoyée en consultation et quand j'ai demandé, j'ai vu qu'elle allaitait. J'ai refusé de prescrire l'antidépresseur.

La patiente n'était pas contente. Ma collègue n'était pas contente. Mais ce n'est pas parce qu'un psychiatre lui prescrivait un antidépresseur que je suis obligée de le faire.

C'est une conduite personnelle. Moi, personnellement, j'épargne à un enfant nouveau-né un traitement psychotrope dont il n'a pas besoin et qu'il n'a pas demandé. Les indications, c'est-à-dire comment on traite les différentes manifestations.

Manifestation anxieuse au cours de la grossesse, manifestation simple anxieuse, ça va de même pour les manifestations anxieuses, les vomissements gravidiques graves, les troubles psychiques mineurs, psychothérapie de soutien. Tout médecin généraliste doit savoir faire. Premier élément de la psychothérapie de soutien, c'est l'écoute.

On avait fait l'écoute active. Oui ou non? Écouter, être empathique avec la patiente, dédramatiser, expliquer, informer sur la grossesse. Non, je ne peux pas gérer.

Essayer d'informer, de donner des informations scientifiques, d'expliquer et surtout d'écouter la patiente, d'écouter les plaintes de la patiente. C'est généralement des perturbations. Dès qu'elle commence à manifester ces symptômes anxieux à la maman, à la belle-maman, au mari, tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière personne qui est tombée enceinte.

Le terme « aïdi » ne doit pas sortir de votre bouche. Quand vous dites « aïdi », c'est normal. Qu'est-ce que vous remettez en question? La souffrance, la légitimité de la plainte.

C'est comme si vous lui dites que tu es en train d'exagérer, tu es en train de simuler. Non, l'empathie, c'est la capacité de comprendre la situation du point de vue de la patiente. Donc l'écoute, toute technique corporelle, je l'ai bien dit, qui vise à faire de la relaxation, yoga, préparation à l'accouchement, tout est le bienvenu.

Par contre, si on a la main forcée, si les manifestations oxytocines sont importantes, l'hydroxyzine, l'atarax, ou l'oxazepam, le Seresta. Le Seresta, c'est une benzodiazépine, c'est un oxylycide qu'on peut prescrire au cours de la grossesse qui n'a pas beaucoup d'effets secondaires. Malheureusement, il n'est pas commercialisé au Maroc.

Les épisodes dépressifs pendant la grossesse, psychothérapie, antidépresseurs qui ont le plus de recul, j'ai donné quelques exemples, j'ai donné ce qu'il ne faut pas prescrire en premier trimestre. Certains timorégulateurs, on peut les prescrire au cours de la grossesse, notamment l'olanzapine, qui est un neuroleptique, la lamotrigine, le lithium, le valproate de sodium, l'acide valproïque sont contre-indiqués formellement au cours de la grossesse. Quand la patiente présente des troubles psychotiques, soit des troubles psychotiques d'apparition nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des antécédents, soit que c'est une patiente qui était déjà connue malade mentale et qui a fait une exacerbation de sa symptomatologie au cours de la grossesse, une hospitalisation généralement psychiatrique s'impose pour stabiliser la patiente.

Les anciens traitements, paradoxalement, les anciens traitements comme l'anopéridole, l'aldol, la chlorpromazine ou l'olanzapine sont les plus documentés en termes de neuroleptiques. En postpartum, pour le boost du postpartum, aucun traitement médical n'est indiqué puisqu'il est de résolution, il va spontanément, il va s'améliorer spontanément. Ce qu'on peut faire, c'est, bien sûr, psychothérapie de soutien mais surtout il faut inclure l'entourage, surtout le papa dans la prise en charge, rassurer la patiente, je parle de l'entourage, rassurer la parturiente ou la maman que comme quoi le papa est là, la famille est là et qu'on va tous être là pour elle jusqu'à ce qu'elle puisse bien prendre en charge ou la prendre jusqu'à ce qu'elle soit prête à prendre en charge son enfant.

Pour la dépression du postpartum, quand le tableau est sévère, hospitalisation, psychothérapie, ECT, électroconvulsivothérapie, c'est cas sévère, l'ECT vous allez le voir en cours à part entière. La psychose du postpartum, urgence thérapeutique, éliminer une cause organique. Si c'est une psychose d'origine psychiatrique, hospitalisation au milieu psychiatrique s'impose, traitement neuroleptique, traitement anxiolytique et bien sûr l'électroconvulsivothérapie si cas sévère.

Ousselina. Maintenant on passe, je vous libère tôt. Maintenant on passe au cours des troubles de la maladie,